

TEMA 7.19 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Consumo de Alcohol: Alcoholismo y Síndromes de Abstinencia

PERFIL EUNACOM 1.09.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El consumo de alcohol es uno de los problemas de salud pública más prevalentes en Chile. Su impacto no se limita únicamente al individuo, sino que afecta profundamente su entorno familiar, laboral y social, además de ser un factor determinante en la carga de morbilidad por enfermedades crónicas y accidentes.

Riesgos Asociados al Consumo de Alcohol

Históricamente, se difundió la idea de que el consumo moderado de alcohol (especialmente el vino tinto) posea beneficios cardioprotectores debido a sus antioxidantes. Sin embargo, la evidencia científica actual es categórica en desmentir este mito.

- **Riesgo Cardiovascular:** El alcohol aumenta el riesgo de hipertensión, arritmias (como la **Fibrilación Auricular**) y eventos coronarios. No existe una dosis "segura" que reduzca el riesgo de infarto.
- **Riesgo Oncológico:** Existe una asociación directa con el cáncer hepático, de esófago, gástrico y de mama. El riesgo de cáncer de esófago se potencia significativamente cuando se combina con el consumo de tabaco.
- **Daño Orgánico:** Desarrollo de **Daño Hepático Crónico** (cirrosis), hepatitis alcohólica aguda y daño cerebral irreversible a largo plazo.
- **Impacto Social:** Accidentes de tránsito, conductas violentas, asaltos y deterioro de las redes de apoyo.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del riesgo: El alcohol actúa como un tóxico sistémico. Sus metabolitos, como el acetaldehído, son pro-inflamatorios y pro-carcinogénicos. A nivel del Sistema Nervioso Central (SNC), el alcohol es un depresor que, con el consumo crónico, genera una **up-regulation** (aumento de sensibilidad y número) de los receptores excitatorios para compensar la depresión constante, lo que explica la clínica de la abstinencia.

Clasificación del Consumo

Es fundamental distinguir entre la dependencia y el consumo que, sin ser dependencia, genera daños.

TABLA 7.19.1: CONCEPTO VS DEFINICIÓN		
CONCEPTO	DEFINICIÓN	CARACTERÍSTICAS
Alcoholismo (Dependencia)	Adicción propiamente tal.	Pérdida de control, craving (deseo intenso), tolerancia y síndrome de abstinencia.
Bebedor Problema (Consumo Perjudicial)	Consumo que genera daño físico o mental.	No necesariamente hay dependencia, pero el consumo provoca consecuencias negativas (peleas, accidentes).
Embriaguez Patológica	Reacción desproporcionada al alcohol.	El paciente presenta cambios conductuales severos (agresividad, llanto, conductas de riesgo) con dosis bajas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El objetivo clínico tanto en el alcoholismo como en el consumo perjudicial es siempre la **abstinencia total**. Si esto falla, se recurre a estrategias de **minimización de daños**, pero nunca como primera opción médica.

Síndrome de Abstinencia Alcohólica

El síndrome de abstinencia aparece cuando un consumidor crónico detiene o reduce bruscamente su ingesta.

1. Abstinencia Leve

Se presenta en las primeras 6 a 24 horas tras el último trago. - Ansiedad e irritabilidad. - Insomnio. - Temblor fino distal. - Malestar general y síntomas autonómicos leves.

2. Abstinencia Severa y Convulsiones

Suele ocurrir entre las 24 y 48 horas (aunque puede extenderse). - Intensificación de los síntomas leves. - **Convulsiones tónico-clónicas generalizadas:** Debido a la hiperexcitabilidad cortical por la falta del efecto depresor del alcohol.

3. Delirium Tremens (Urgencia Médica)

Es la forma más grave de abstinencia, presentándose habitualmente entre el **2º y 4º día** de cese del consumo. Se define por una tríada clásica:

- **Temblor:** Puede ser grueso y generalizado.
- **Alucinaciones (Microzoopsias):** Percepción de animales pequeños (arañas, ratas, serpientes) que suelen atacar al paciente.
- **Agitación Psicomotora:** Desorientación temporal y espacial con intensa activación autonómica (taquicardia, sudoración, hipertensión).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **Delirium Tremens** tiene una mortalidad significativa si no se trata a tiempo. A diferencia de otros cuadros de agitación psiquiátrica, el manejo de primera línea **NO es el haloperidol**, sino las benzodiacepinas.

Manejo Farmacológico de la Abstinencia

El tratamiento de elección son las **Benzodiacepinas**, ya que presentan tolerancia cruzada con el alcohol y ayudan a estabilizar la excitabilidad del SNC.

- **Diazepam:** Es el fármaco de elección por su vida media larga, lo que permite una depuración más suave y previene mejor las convulsiones. Se suele administrar vía oral o endovenosa según la gravedad.
- **Lorazepam:** Se prefiere en pacientes con **Daño Hepático Crónico** o insuficiencia hepática aguda, ya que su metabolismo no depende tanto de la función del hígado (no tiene metabolitos activos de larga duración).

TABLA 7.19.2: ESCENARIO VS FÁRMACO PREFERIDO		
ESCENARIO	FÁRMACO PREFERIDO	RAZÓN
Abstinencia estándar / DT	Diazepam	Vida media larga, mayor estabilidad.
Abstinencia en Círrótico	Lorazepam	Menor compromiso metabólico hepático.

EUNACOM CRITERIOS

En el EUNACOM, es común que presenten a un paciente hospitalizado por otra causa (ej. fractura o neumonía) que comienza con agitación y alucinaciones al tercer día. Siempre sospeche **Abstinencia Alcohólica** oculta.

Otros Síndromes de Abstinencia Importantes

Abstinencia a Benzodiazepinas

Ocurre en pacientes que consumen benzodiazepinas de forma crónica (como ansiolíticos o hipnóticos) y las suspenden de golpe. -

Clínica: Muy similar a la del alcohol (ansiedad, temblor, insomnio, crisis de pánico). Es raro ver microzoopsias, pero pueden ocurrir convulsiones. - **Manejo:** Reiniciar la benzodiazepina y realizar un traslape a una de vida media larga para luego hacer un **retiro gradual** (tapering).

Síndrome de Discontinuación de ISRS

Ocurre al suspender bruscamente antidepresivos como la Sertralina o Fluoxetina. - **Clínica:** Ansiedad, insomnio y un cuadro "**Flu-like**" (pseudogripal): mialgias, cefalea, escalofríos y malestar general. -

Manejo: Educación al paciente (advertir que es temporal) y reinstaurar el fármaco para bajar la dosis de manera progresiva durante 2 semanas.

Abstinencia a la Cafeína

Frecuente en consumidores de altas dosis de café que cesan el consumo bruscamente. - **Clínica:** Cefalea intensa, fatiga, somnolencia y síntomas "Flu-like". - **Manejo:** Educación y reducción gradual del consumo. No es grave, pero es un diagnóstico diferencial de cefalea en el paciente ambulatorio.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerde: Ante cualquier cuadro de agitación psicomotora con antecedentes de consumo de sustancias, la prioridad es estabilizar hemodinámicamente, descartar causas orgánicas (hipoglucemia, hipoxia) y tratar la abstinencia con el régimen de benzodiazepinas adecuado.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 50 años, alcohólico crónico, fue hospitalizado por una fractura de cadera. Al 3er día de hospitalización se agita, dice que ve ratas que salen de las paredes y lo atacan, y tiene temblor grueso de manos. El familiar refiere que el paciente nunca mencionó ser alcohólico. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Consumo de Alcohol: Alcoholismo y Síndromes de Abstinencia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Delirium Tremens: tríada de temblor + microzoopsias (alucinaciones de pequeños animales) + agitación; ocurre 2-4 días post-cese del alcohol.
- Tratamiento del Delirium Tremens: benzodiazepinas (diazepam); en daño hepático usar lorazepam. NO usar haloperidol.
- El síndrome de abstinencia al alcohol severo puede provocar convulsiones a los 2-4 días del cese del consumo.
- El objetivo del tratamiento del alcoholismo siempre es la abstinencia total; la minimización de daños es la última opción.
- La borrachera patológica: persona tranquila sin alcohol que con alcohol entra en conductas desadaptativas graves.
- El síndrome de discontinuación de ISRS: síntomas ansiosos + flu-like (mialgias, cefalea, sin fiebre); se previene con reducción gradual.
- Los estudios actuales muestran que no hay nivel seguro de consumo de alcohol; el consumo moderado también aumenta riesgo cardiovascular y de cáncer.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONSUMO DE ALCOHOL: ALCOHOLISMO Y SÍNDROMES DE ABSTINENCIA)**PREGUNTA 1**

Hombre de 50 años, alcohólico crónico, fue hospitalizado por una fractura de cadera. Al 3er día de hospitalización se agita, dice que ve ratas que salen de las paredes y lo atacan, y tiene temblor grueso de manos. El familiar refiere que el paciente nunca mencionó ser alcohólico. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo?

- A)** Psicosis aguda; haloperidol 5 mg IM
- B)** Delirium Tremens por abstinencia alcohólica; diazepam IV o IM
- C)** Encefalopatía hepática; restricción proteica y lactulosa
- D)** Delirium por fractura de cadera; haloperidol en dosis bajas
- E)** Intoxicación por alcohol; observación y suero fisiológico

PREGUNTA 2

Paciente de 45 años con alcoholismo e insuficiencia hepática crónica presenta un Delirium Tremens. ¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo?

- A)** Diazepam 10 mg IV
- B)** Haloperidol 5 mg IM
- C)** Lorazepam IV (no se metaboliza tan extensamente en el hígado)
- D)** Olanzapina oral
- E)** Naltrexona IV

PREGUNTA 3

Mujer de 38 años en tratamiento por depresión con sertralina 50 mg/día decide suspenderla de forma brusca porque "ya no la necesita". A los 3 días llama angustiada porque siente hormigueos en el cuerpo, tiene cefalea, se siente como resfriada y está muy ansiosa. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Recaída de la depresión
- B)** Gripe intercurrente; antipiréticos
- C)** Síndrome de discontinuación de ISRS; educación y reducción gradual
- D)** Intoxicación por sertralina; carbón activado
- E)** Trastorno de pánico por abstinencia a benzodiacepinas

RESUMEN: CONSUMO DE ALCOHOL: ALCOHOLISMO Y SÍNDROMES DE ABSTINENCIA

El alcohol es una sustancia con múltiples efectos deletéreos: daño hepático crónico, hepatitis alcohólica aguda, daño cerebral, aumento del riesgo de cáncer hepático y esofágico (potenciado por tabaco), y aumento del riesgo cardiovascular. Los estudios actuales demuestran que no existe un nivel de consumo seguro. El alcoholismo (dependencia al alcohol) se distingue del bebedor problema (consumo perjudicial): en ambos casos el objetivo del tratamiento es la abstinencia total. La borrachera patológica o embriaguez patológica describe a la persona que sin alcohol es tranquila pero que con alcohol entra en conductas desadaptativas (peleas, gastos impulsivos, sexo de riesgo, manejo bajo los efectos del alcohol). El manejo es igual al de la dependencia. El síndrome de abstinencia al alcohol es una urgencia médica. En su forma leve: ansiedad, insomnio, temblor. En su forma severa, que ocurre 2 a 4 días después del cese del consumo: convulsiones. El Delirium Tremens es la forma más grave: tríada de temblor + microzoopsias (alucinaciones de pequeños animales) + agitación psicomotora. El tratamiento del síndrome de abstinencia leve es soporte; el severo y el Delirium Tremens requieren benzodiacepinas (diazepam de preferencia; en daño hepático se usa lorazepam, que no se metaboliza tanto en el hígado). No usar haloperidol ni antipsicóticos en el Delirium Tremens; solo si no responde a benzodiacepinas. El síndrome de abstinencia a benzodiacepinas es similar al del alcohol (ansiedad, temblor, convulsiones). El síndrome de discontinuación de los ISRS se caracteriza por síntomas ansiosos + síndrome flu-like (sin fiebre). El síndrome de abstinencia a la cafeína produce cefalea y somnolencia. En todos los casos el tratamiento principal es la educación y la reducción gradual cuando corresponde.